

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-COMUNICATIVO DO BEBÊ: PISTAS PARA DETECÇÃO PRECOCE DE TEA

13.05.2025

Ana Osório

**Programa de pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento
Humano - Mackenzie**

ana.osorio@mackenzie.br

TEA

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)

- ✓ Síndrome neurodesenvolvimental
- ✓ Diagnóstico clínico comportamental
- ✓ Espectro de severidade dos sintomas (Dimensional vs. Categorical)
- ✓ Caracteriza-se por **dificuldades em dois domínios** (DSM-5):
 - A. Défices de interação e comunicação social
 - B. Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades

TEA

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)

- ✓ Síndrome neurodesenvolvimental
- ✓ Diagnóstico clínico comportamental
- ✓ Espectro de severidade dos sintomas (Dimensional vs. Categorical)
- ✓ Caracteriza-se por **dificuldades em dois domínios** (DSM-5):



A. **Dificuldades na interação e comunicação social**

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades

TEA

A. Dificuldades sociais e de comunicação

Déficits clinicamente significativos e persistentes na **comunicação social** e nas **interações sociais**, observados em múltiplos contextos:

1. Déficits na reciprocidade socio-emocional, por exemplo:

- ✓ Aproximação social atípica
- ✓ Reduzida partilha de interesses, emoções ou afetos
- ✓ Falhas em iniciar ou responder a interações sociais

TEA

2. Déficits nos comportamentos comunicativos não-verbais usados na interação social, por exemplo:

- ✓ Padrões atípicos de contato ocular e linguagem corporal
- ✓ Dificuldades na compreensão e uso de gestos de comunicação social
- ✓ Expressões faciais e comunicação não verbal

3. Déficits em desenvolver, manter e compreender relações sociais

TEA

A. Dificuldades de interação e comunicação social



TEA

Os sintomas devem estar presentes desde **fases precoces do desenvolvimento** (embora possam não se manifestar totalmente até que as demandas sociais excedam as suas capacidades, ou podem até ser mascaradas por estratégias aprendidas ao longo da vida).



IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO PRECOCE

IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO PRECOCE

- Permite **intervenções especializadas** em um momento de **maior plasticidade cerebral – infância**
- Aplicação de **terapias específicas** no sentido de **promover a comunicação e interação social, bem como melhorias comportamentais**
- **Prevenção da consolidação de padrões disfuncionais** de comportamento, comunicação e interação social
- **Melhores prognósticos**

APRENDA OS SINAIS: AJA PRECOCEMENTE

- Recursos criados pelo Center for Disease Control & Prevention dos E.U.A.
- Educação das **famílias** sobre marcos do desenvolvimento e comportamento infantil – dos 2 meses aos 5 anos
- <https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/>
 - https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/other-lang/Brazilian-Portuguese-Checklists_LTSAE-P.pdf
- www.autismnavigator.com (com vídeos de exemplo de sinais precoces até 24 meses)
- Autism Navigator® ASD Video Glossary

 Centers for Disease Control and Prevention
CDC 24/7: Saving Lives. Protecting People™

Learn the Signs. Act Early.

Help your child grow and thrive

   **Download CDC's free Milestone Tracker app**
One million downloads and counting!

 Track & Share Milestones |  Get Tips & Activities |  Learn When to Act Early

Learn more at cdc.gov/MilestoneTracker



ASD Video Glossary

For families and professionals who wish to **learn more** about the early signs of autism in toddlers. Uses side-by-side video clips showing behaviors that are typical in contrast with those that are red flags for autism.

[OPEN VIDEO GLOSSARY](#)

M-CHAT

- Ferramenta de rastreio – útil aos 24 meses da criança
- Portugal - https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_Portuguese_Portugal.pdf
- Brasil - https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2020/09/M-CHAT-R_F_Brazilian_Portuguese_v2.pdf

Dada a importância da detecção precoce

Relembrando....

A. Dificuldades de interação e comunicação social



ATENÇÃO COMPARTILHADA

Habilidade sócio-cognitiva que surge e se desenvolve marcadamente em **período crítico** para detecção precoce de sintomas de TEA
9-24 meses

ATENÇÃO COMPARTILHADA

- Emerge último trimestre do 1º ano de vida (9-12 meses)
- Importante marcador do desenvolvimento típico da cognição social
- Coordenação triádica entre o bebê, um parceiro social (ex. a mãe) e um objeto ou evento externo
- Partilha do interesse ou prazer relacionados, por exemplo, a um brinquedo ou acontecimento
 - Um brinquedo que faz música e pisca
 - Um passarinho que canta na janela

ATENÇÃO COMPARTILHADA

- **Responsividade** do bebê às sugestões de atenção compartilhada do adulto → **RAC**
 - O bebê responde às solicitações do adulto, procurando visualmente o seu foco de atenção, utilizando como pista a sua linha de visão ou gestos (como apontar).
- **Iniciação** de atenção compartilhada pelo próprio bebê → **IAC**
 - O bebê procura iniciar/dirigir a atenção do adulto utilizando para isso gestos como apontar, oferecer ou mostrar um brinquedo.

ATENÇÃO COMPARTILHADA - RAC





ATENÇÃO COMPARTILHADA - IAC





TEA E ATENÇÃO COMPARTILHADA

- ✓ Déficits persistentes em demonstrar comportamentos quer do tipo RAC e **IAC***

Estudos mostram:

- ✓ *Diferenças quantitativas*
 - ✓ Atraso na demonstração de AC (Naber et al, 2007)
 - ✓ Menor frequência de AC (Kasari et al., 1993)
- ✓ *Diferenças qualitativas*
 - ✓ Padrões atípicos de AC (Carpenter et al., 2002)

✓ Déficits de AC são aspetos centrais do diagnóstico precoce de TEA e incorporam o critério A1:

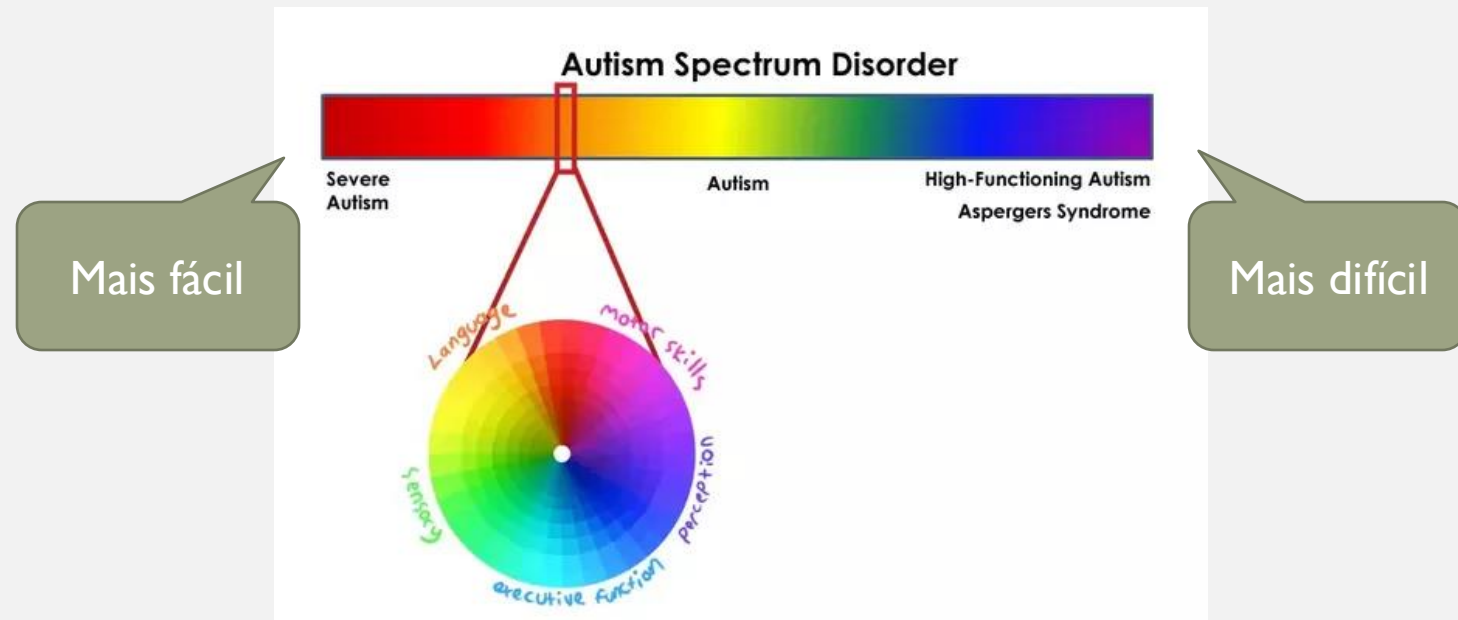
- ✓ Reduzida partilha de interesses, emoções ou afetos
- ✓ Falhas em iniciar ou responder a interações sociais

E A2:

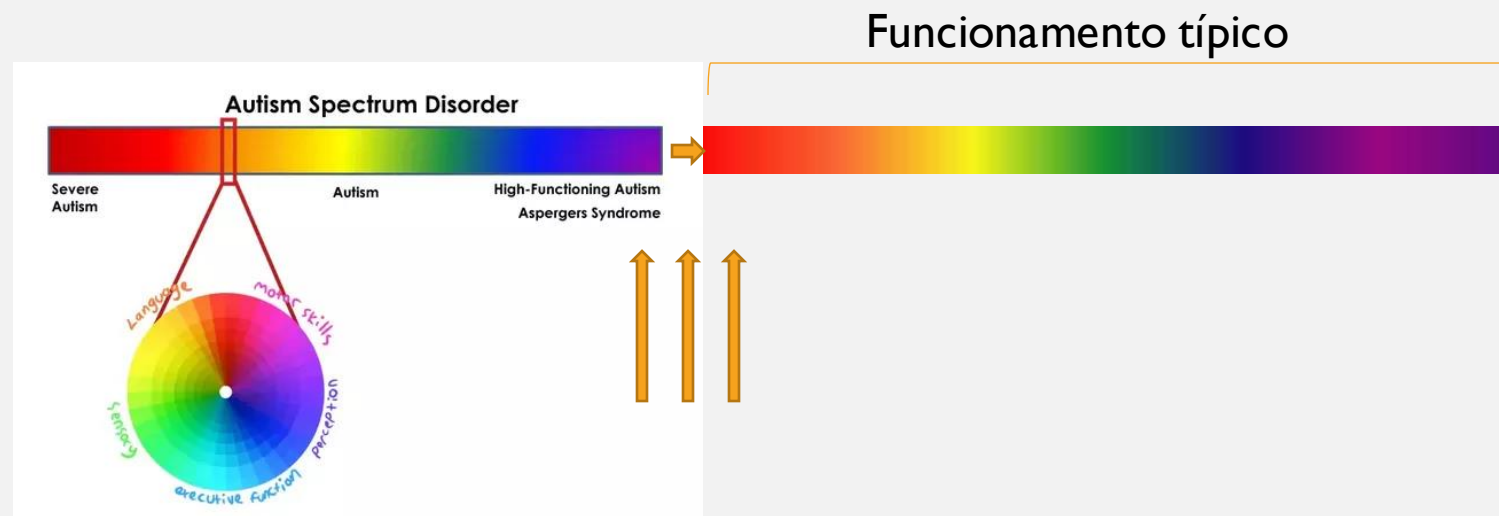
- ✓ Padrões atípicos de contato ocular e linguagem corporal
- ✓ Déficits na compreensão e uso de gestos de comunicação social
- ✓ Expressões faciais e comunicação não verbal

DIFICULDADES NA DETECÇÃO PRECOCE

- Na teoria, distinção entre desenvolvimento típico e atípico da atenção compartilhada é simples...
- Na prática, nem tanto!
- **Desenvolvimento precoce** ocorre de forma **muito rápida** e pode apresentar **timings e trajetórias distintos** – mesmo dentro do **Desenvolvimento Típico**
- **TEA - Espectro**



DIFICULDADES NA DETECÇÃO PRECOCE



- Casos extremos – mais simples, diretos
- **Casos mais próximos do desenvolvimento típico** – mais difíceis

DIFICULDADES NA DETECÇÃO PRECOCE

- Atenção Compartilhada – **desempenhos muito variáveis**, mesmo crianças que vêm a demonstrar uma **trajetória típica**



- Exemplo estudo longitudinal - Tese doutorado Elisangela Vieira (repositório Mackenzie)
 - Bebês prematuros e a termo
 - Avaliados aos **12 e 18 meses**
 - **Atenção compartilhada** (por observação de comportamentos com pesquisador) aos 12 e 18 meses
 - **M-CHAT** (questionário nível I para rastreio de sintomas TEA) aos 18 meses

DIFICULDADES NA DETECÇÃO PRECOCE

- **Variação IAC**

- 12M: 5-47 ocorrências; Média = 26
- 18M: 6-44 ocorrências; Média = 25



- **Variação RAC**

- 12M: 6-94%; Média = 49%
- 18M: 12-100%; Média = 77%



Apenas 1 criança sinalizada nos itens críticos do M-CHAT

Prematuro, sexo masculino

DIFICULDADES NA DETECÇÃO PRECOCE

Itens críticos M-CHAT assinalados pela mãe aos 18 meses:

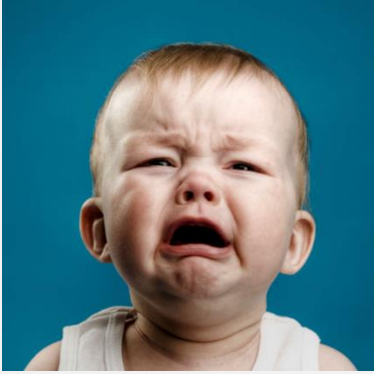
- *Interessa-se pelas outras crianças?* **Não**
- *Aponta com o indicador para mostrar interesse em alguma coisa?* **Não**
- *Alguma vez lhe trouxe objetos (brinquedos) para lhe mostrar alguma coisa?* **Não**
- *Se apontar para um brinquedo do outro lado da sala, a criança acompanha com o olhar?* **Não**

- **Curiosamente, na avaliação da Atenção Compartilhada:**

- Variação IAC
 - 12M: 18 ocorrências
 - 18M: 25 ocorrências
- Variação RAC
 - 12M: 54%
 - 18M: 88%

**Evolução positiva nas 2 dimensões
Sem sinais de alerta evidentes**

Ozonoff et al., 2010 já alertavam para a dificuldade dos pais relatarem com fidedignidade desenvolvimento social retrospectivo



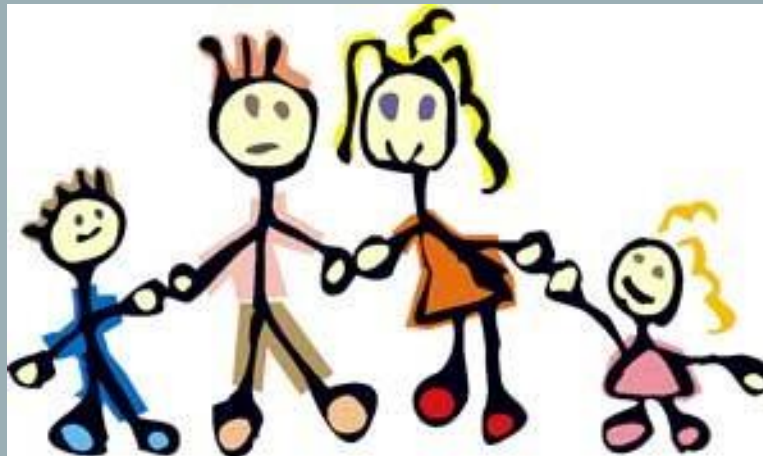
O QUE FAZER?

- **Ter claro o alcance/utilidade, mas também as limitações inerentes a avaliações:**
 - Único momento
 - Único tipo de evidência/comportamento
 - Único contexto
 - Único interlocutor
 - Único informante
 - Único formato

O QUE FAZER?

- **Idealmente, um rastreio positivo para TEA deverá ser resultado de avaliações em:**
 - **Vários momentos** (acompanhamento contínuo + rastreio em fases críticas do desenvolvimento sócio-emocional)
 - Com base em **evidências de diferente natureza** – ex. atenção compartilhada, linguagem, cognição geral, comportamento
 - Avaliadas em **diferentes contextos e com diferentes pessoas** – ex. interações com a mãe; interações com um profissional
 - Com base em **vários informantes** – ex. relatos parentais, observações diretas
 - Em **vários formatos** – ex. observação clínica, questionário, escala de avaliação

Obrigada!



Questões?

ana.osorio@mackenzie.br

PROJETO @BEBE.CIENTISTA

